Camila Kammers

MATERIAL DE REFERÊNCIA CIENTÍFICA
CONGRESSO VOZES DO AUTISMO
IJUÍ-RS · 2026

PRESENTE DA PALESTRA

Sono no TEA

Material de referência científica sobre sono no Transtorno do Espectro Autista, voltado a profissionais e famílias de crianças e adolescentes. Consulte sempre que precisar compreender, orientar ou tomar decisões sobre o sono com base em evidências.

Dra. Camila Kammers

SEÇÃO 01

Sinais de alerta de privação de sono

A privação de sono não se manifesta de forma única ou isolada. Em crianças e adolescentes, especialmente no TEA, seus efeitos são amplos e impactam diferentes áreas do funcionamento. Os sinais costumam aparecer de forma **combinada** e, muitas vezes, são interpretados como dificuldades específicas — quando na realidade podem ter como base um sono insuficiente ou não reparador.

Comportamento

- Irritabilidade frequente
- Crises emocionais mais intensas
- Baixa tolerância à frustração
- Hiperatividade (principalmente em crianças pequenas)
- Impulsividade aumentada
- Dificuldade em seguir regras ou limites

Aprendizado e atenção

- Dificuldade de concentração
- Queda no rendimento escolar
- Esquecimento frequente
- Dificuldade em consolidar novos aprendizados
- Lentidão cognitiva ou desorganização

Regulação emocional

- Maior reatividade emocional
- Oscilações de humor
- Ansiedade aumentada
- Dificuldade de autorregulação
- Maior dependência do adulto para se acalmar

Sinais diretos do sono

- Dificuldade para acordar pela manhã
- Sonolência durante o dia
- Dormir mais aos finais de semana
- Mau humor ao acordar
- Necessidade excessiva de sonecas (fora da idade esperada)
- Despertares noturnos frequentes
- Resistência para dormir

Relação familiar

- Aumento do estresse familiar
- Exaustão dos cuidadores
- Maior conflito nas rotinas (principalmente à noite)
- Dificuldade de manter consistência nas intervenções

Sinais frequentemente confundidos no TEA

- "Piora do comportamento"
- "Regressão" em habilidades
- "Desobediência"
- "Falta de atenção"

IMPORTANTE

A privação de sono nem sempre aparece como "cansaço". Em crianças, e de forma ainda mais evidente no TEA, ela frequentemente se manifesta como desorganização comportamental, dificuldade de aprendizado ou alterações emocionais.

Por isso, é fundamental olhar além do óbvio e considerar o sono como um fator central no funcionamento da criança.

Se vários desses sinais estão presentes, é importante investigar o sono de forma mais aprofundada.

SEÇÃO 02

Quantidade de sono por idade

Embora cada criança tenha suas particularidades, existem recomendações baseadas em evidências científicas que orientam o tempo de sono necessário para sustentar o desenvolvimento saudável.

A seguir, você encontra as recomendações da **National Sleep Foundation**, amplamente utilizadas como referência clínica.

FAIXA ETÁRIA	HORAS / DIA	OBS.
0 a 3 meses	14–17h	c/ sonecas
4 a 11 meses	12–15h	c/ sonecas
1 a 2 anos	11–14h	c/ sonecas
3 a 5 anos	10–13h	c/ soneca
6 a 13 anos	9–11h	noturno
14 a 17 anos	8–10h	noturno

Importante: As horas são uma referência — não devem ser analisadas isoladamente. Avalie também a **qualidade**, a **regularidade**, o comportamento diurno e a facilidade para adormecer e acordar.

SEÇÃO 03

Recomendações práticas baseadas em evidência

A diretriz da **American Academy of Neurology** recomenda que, diante de problemas de sono no TEA, sejam avaliados fatores comportamentais, condições médicas coexistentes e medicamentos em uso antes de avançar para tratamento farmacológico.

Os três pilares do sono reparador

- **Quantidade**
  Horas totais de sono em 24h, incluindo sono noturno e sonecas
- **Qualidade**
  Continuidade, ausência de sono agitado, facilidade de retornar ao sono
- **Regularidade**
  Horários consistentes para dormir e acordar, inclusive fins de semana

Os 7 pilares de intervenção

1 Rotina e previsibilidade

- Manter horário regular para dormir e acordar, inclusive aos finais de semana
- Criar uma sequência curta e repetitiva antes de dormir: banho, pijama, história, cama
- Usar rotina visual com figuras, cartões ou quadro de sequência
- Antecipar mudanças com aviso prévio: "faltam 10 minutos para dormir"
- Evitar negociações longas ou mudanças frequentes na rotina
- Garantir exposição à luz natural pela manhã

2 Ambiente de sono

Muitas crianças com TEA têm hipersensibilidade sensorial, o que pode afetar o início e a manutenção do sono.

- Quarto completamente escuro e silencioso
- Temperatura ideal entre 18 e 22 °C
- Evitar excesso de estímulos visuais no quarto
- Manter o quarto previsível e associado ao descanso
- Não usar a cama para brincadeiras, alimentação ou telas

3 Organização do dia e ritmo circadiano

- Expor a criança à luz natural pela manhã e ao longo do dia
- Manter horários regulares das principais refeições
- Incentivar atividade física adequada durante o dia
- Evitar atividades muito estimulantes próximo ao horário de dormir
- Observar se sonecas tardias ou longas atrapalham o sono noturno

4 Telas e estimulação noturna

- Retirar telas 1 a 2 horas antes de dormir
- Evitar celular, tablet, televisão e jogos no quarto
- Substituir por leitura, história, música tranquila ou rotina visual
- Reduzir luz intensa no período noturno

5 Alimentação

- Manter refeições principais com regularidade
- Evitar cafeína à tarde e à noite
- Evitar excesso de açúcar próximo ao horário de dormir
- Preferir jantar leve, com intervalo adequado antes de deitar
- Observar refluxo, constipação, alergias ou desconfortos que fragmentem o sono

6 Associações de sono e autonomia

Associações de sono são condições que a criança aprende a precisar para adormecer. Algumas são simples; outras difíceis de manter (colo, carro, mamadeira, tela).

- Evitar dependências difíceis de sustentar durante a madrugada
- Se já houver associação forte, fazer retirada gradual
- Fazer a criança adormecer e amanhecer no mesmo lugar
- Conduzir despertares de forma previsível, breve e consistente

7 Regulação sensorial

Algumas crianças chegam à noite sobrecarregadas; outras buscam estímulos. A intervenção deve considerar o perfil sensorial individual.

- Observar se a criança precisa reduzir estímulos antes de dormir
- Ajustar luz, som, temperatura, textura de roupas e cobertas
- Usar estratégias calmantes: banho morno, pressão profunda, objeto de conforto
- Manter sequência previsível de desaceleração

Quando buscar profissional especializado

O sono é multifatorial, especialmente no TEA. Quando os ajustes não são suficientes, um olhar técnico permite:

- Identificar fatores não evidentes no dia a dia
- Estruturar um plano de intervenção individualizado
- Ajustar estratégias de forma progressiva e segura
- Avaliar necessidade de investigação médica

SEÇÃO 04

Referências bibliográficas

26 referências científicas que embasam o conteúdo deste material.

1 Mason GM, Lokhandwala S, Riggins T, Spencer RMC. Sleep and human cognitive development. *Sleep Med Rev.* 2021;57:101472.

2 Carskadon MA, Dement WC. Monitoring and staging human sleep. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC (Eds.), *Principles and practice of sleep medicine*, 5th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2011. pp. 16–26.

3 Baranwal N, Yu PK, Siegel NS. Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene. *Prog Cardiovasc Dis.* 2023;77:59–69.

4 Gobetti RAP, Prado LBF, Carvalho LBC, Bueno C, Soster LSA. Distúrbios do Sono. In: Masruha M, Vilanova LCP. *Neurologia Infantil – Fundamentos e Prática Clínica.* São Paulo: Editora dos Editores; 2023. p. 727–792.

5 Schlieber M, Han J. The Role of Sleep in Young Children's Development: A Review. *J Genet Psychol.* 2021;182(4):205–217.

6 Elrod MG, Hood BS. Sleep differences among children with ASD and typically developing peers: a meta-analysis. *J Dev Behav Pediatr.* 2015;36(3):166–177.

7 Johnson KP, Zarrinnegar P. Autism Spectrum Disorder and Sleep. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2021;30(1):195–208.

8 Nogueira HA et al. Melatonin for sleep disorders in people with autism: Systematic review and meta-analysis. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2023;123:110695.

9 Johnson KP, Zarrinnegar P. Autism Spectrum Disorder and Sleep. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2021;30(1):195–208.

10 Lee T, Kim J, Park KJ, Kim HW. Sleep difficulties and related behavioral problems in Korean preschool children. *Sleep Med.* 2021;87:119–126.

11 Madrid-Valero JJ et al. Children Sleep and Antisocial Behavior. *J Abnorm Child Psychol.* 2019;47(5):791–799.

12 Souders MC et al. Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder. *Curr Psychiatry Rep.* 2017;19(6):34.

13 Hayashi M et al. Melatonin Treatment and Sleep Hygiene Interventions in Children with ASD: A RCT. *J Autism Dev Disord.* 2022;52(6):2784–2793.

14 Bathory E, Tomopoulos S. Sleep Regulation, Physiology and Development in Young Children. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care.* 2017;47(2):29–42.

15 Agostini A, Centofanti S. Normal Sleep in Children and Adolescence. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.* 2021;30(1):1–14.

16 Schreck KA, Richdale AL. Sleep problems, behavior, and psychopathology in autism. *Curr Opin Psychol.* 2020;34:105–111.

17 Miano S, Giannotti F, Cortesi F. Sleep Disorders and ASD. In: Mazzone L, Vitiello B (eds). Springer, Cham; 2016.

18 Tecar C et al. Sleep Disturbances and Behavioral Problems in Children with ASD — A Systematic Review. *Clinics and Practice.* 2025;15(11):201.

19 Meltzer LJ, Mindell JA. Behavioral interventions for pediatric insomnia. *J Pediatr Psychol.* 2014;39(8):932–948.

20 Ogundele MO, Yemula C. Management of sleep disorders in children with neurodevelopmental disorders. *World J Clin Pediatr.* 2022;11(3):239–252.

21 Whelan S et al. Sleep Quality, Social Functioning, and Behavior Problems in Children with ASD: A Systematic Review. *Nature and Science of Sleep.* 2022.

22 Auger RR et al. Clinical Practice Guideline for Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders. *J Clin Sleep Med.*

23 Lawson LP et al. ACT-i, an insomnia intervention for autistic adults: a pilot study. *Behav Cogn Psychother.* 2023;51(2):146–163.

24 Cortese S et al. Sleep Disorders in Children and Adolescents with ASD. *CNS Drugs.* 2020;34(4):415–423.

25 McPhee PG et al. Harmonizing data on correlates of sleep in children with neurodevelopmental

disorders. *Front Neuroinform.* 2024;18:1385526.

26 Petruzzelli MG et al. Sleep Parameters in Children and Adolescents with ASD: A Systematic Review. *J Clin Med.* 2021;10(17):3893.

SEÇÃO 05

Sobre a Camila

Dra. Camila Kammers

Consultora de Sono Infantil e Adolescência

A Dra. Camila Kammers é graduada em Fisioterapia, especializada em sono infantil e na adolescência, pós-graduada em Neurodesenvolvimento e seus Transtornos, pós-graduanda em Autismo, com formação em Neurociências e com anos de experiência acompanhando famílias que sofrem com a privação de sono. Ela sabe que uma noite bem dormida transforma não apenas o bebê, mas toda a dinâmica familiar.

Seu método combina evidências científicas atualizadas com uma abordagem gentil e respeitosa ao desenvolvimento da criança — sem técnicas de choro controlado, sem rigidez, com resultados reais já nos primeiros dias.

Entre em contato

INSTAGRAM
@camilakammers

SITE
camilakammers.com.br

WHATSAPP
Entre em contato